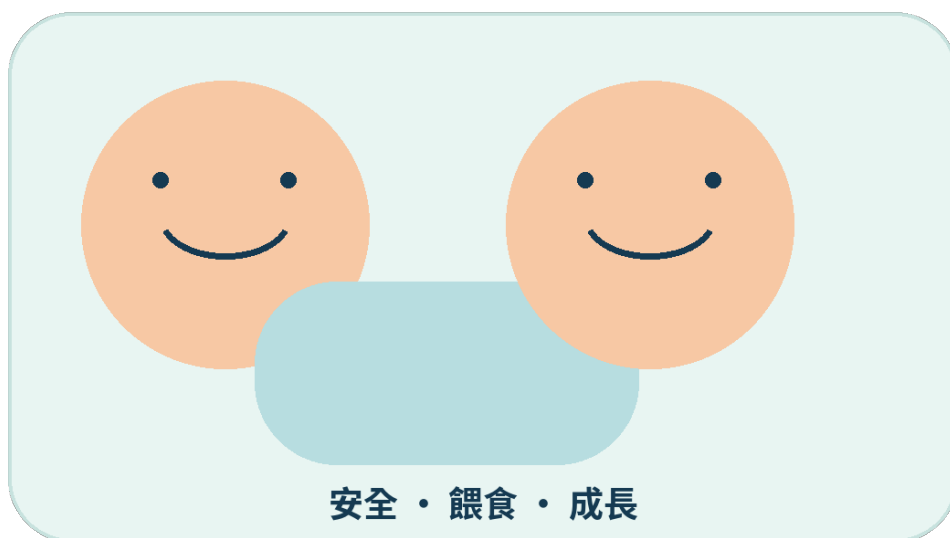


初生 BB 由第 1 日到半歲

英國實用照顧與安全教科書 | 按日、週、月順序 | 2026-27 版



資料查核日期：2026 年 8 月 18 日 | 適用地區：英格蘭（含 Nuneaton／Warwickshire）

安全睡眠 | 餵奶 | 尿片 | 疫苗 | 急救 | 加固 | 本地求助

重要：生命危險 call 999；急需判斷 call NHS 111

目錄

使用說明	3	第 11 章 第 5-6 個月	25
30 秒緊急判斷卡	4	第 12 章 約 6 個月	27
全書路線圖	6	技能課 A 餵奶	29
第 1 章 出生後 0-2 小時	8	技能課 B 睡眠	31
第 2 章 第 1 日	10	技能課 C 急救	33
第 3 章 第 2-3 日	12	技能課 D 病徵分流	35
第 4 章 第 3-7 日	14	技能課 E 家居與外出	37
第 5 章 第 1-2 週	16	技能課 F 照顧者身心	38
第 6 章 第 3-4 週	17	附錄 1 月齡檢查清單	40
第 7 章 第 5-8 週	19	附錄 2 疫苗日曆	41
第 8 章 第 2-3 個月	20	附錄 3 Nuneaton 求助	42
第 9 章 第 3-4 個月	22	附錄 4 記錄表	43
第 10 章 第 4-5 個月	23	資料來源	44

使用說明

注意 | 先講清楚：呢本係安全導航，不係個別診斷

內容按 2026 年 8 月仍有效嘅英國官方指引整理，目標係幫你知道『平時點做』、『邊啲情況要即刻求助』。早產、低出生體重、有心肺／代謝疾病、餵食困難或出院時有特別計劃嘅 BB，一律以醫院、新生兒科、助產士或健康訪視員（health visitor）嘅個別指示為先。

語言說明：本文用廣東話書面語講解；醫療服務及用品保留常見英文名，方便你嚟英國求助或購買。任何時候你覺得 BB『唔似平時』或情況急速轉差，都唔好因為清單未完全符合而等。照顧者直覺係重要警號。

安全標籤點睇

標籤	意思	你要做咩
紅色 立即	可能危及生命	call 999／去 A&E；如果 BB 無正常呼吸，即刻開始 CPR
橙色 緊急	需即日醫療判斷	立即 call NHS 111、GP、midwife 或按指示去急症
綠色 每日	日常最重要做法	變成固定習慣；照顧者之間用同一套做法
藍色 理解	正常變化或技巧	觀察趨勢，唔用單一數字判斷 BB 好唔好

更新規則：疫苗時間表、藥物劑量、產品安全標準同本地電話可能改。每次覆診、打針或用藥前，請再睇 NHS／藥物標籤或問專業人員。

30 秒緊急判斷卡

立即 | 立即 call 999 / 去 A&E

以下任何一項都唔好等：

- 無正常呼吸、只係喘氣 (gaspings)、呼吸停頓；嘴唇／舌頭變藍灰；極度呼吸困難、呻吟 (grunting) 或肋骨下凹。
- 叫唔醒、突然軟癱、反應明顯異常、抽搐；或你覺得 BB 正快速轉差。
- 皮疹用透明玻璃壓住仍不褪色；皮膚異常蒼白、灰、斑駁兼冰冷濕黏。
- 綠色膽汁樣嘔吐、吐血；嚴重噴射式嘔吐兼精神差；疑似吞咗鈕扣電池或磁石。
- 哽塞而無法咳、哭或呼吸；按本書急救步驟做，同時求援。

緊急 | 體溫門檻：唔好自行觀察到第二日

用數碼探熱針量腋下：0–3 個月 $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ ；3–6 個月 $\geq 39.0^{\circ}\text{C}$ ；任何月齡 $< 36.0^{\circ}\text{C}$ 而量度確認，均需立即尋求醫療評估。NHS 不同頁面對『111 或 999/A&E』嘅入口字眼略有差異；實用做法係：BB 精神、呼吸或顏色有異常就 999；仍清醒、呼吸正常亦要即刻 call 111，唔好等。疫苗後 48 小時發燒可能常見，但只可睇 BB 其他方面正常並按疫苗指引時觀察。

緊急 | 其他即日求助

立即 call 111 / GP / midwife：食量明顯少、持續難喚醒、哭聲異常、12 小時無濕片、黃疸首 24 小時出現、臍帶周圍紅腫擴散／流膿、眼口皮膚有水泡或接觸過唇瘡後不適。



圖 1 / BB 唔舒服時嘅求助次序。紅旗優先於任何網上自我評估。

英國求助入口	用途
999	生命危險、嚴重呼吸困難、無反應、抽搐、嚴重哽塞
NHS 111／111 online	急需判斷但未見即時生命危險；嬰兒建議直接打電話，描述月齡、體溫、呼吸、食量、濕片
GP／midwife／health visitor	餵食、體重、黃疸、臍帶、皮膚、發展、照顧者情緒等即日或日常問題
藥劑師 pharmacist	非緊急用藥、用品、劑量器具；嬰兒有病徵仍需醫療評估

全書路線圖：由第 1 日順住去到 6 個月

時間	主要任務	高風險位／預約
出世後 0–24 小時	保暖、肌膚接觸、第一次餵奶、維他命 K、第一次尿／胎糞	安全睡眠；呼吸、顏色、體溫；黃疸若首 24 小時出現係急症
第 2–3 日	按需頻密餵奶、學含乳／安全沖奶、觀察過渡便	奶量不足、過度嗜睡、無尿／無便、黃疸加深
第 4–7 日	日 5 heel-prick、達到濕片指標、臍帶乾燥護理	由第 5 日通常 ≥ 6 塊重濕片；體重／餵食檢查
第 2 週	midwife 交接、health visitor new-baby review、聽力篩查、註冊 GP	臍帶感染、持續黃疸、未回升體重趨勢
第 3–4 週	建立簡單日夜提示、tummy time、應對哭鬧	哭聲異常／發燒；照顧者極度疲倦時防止搖 BB
第 5–8 週	6–8 週 GP/NIPE 覆檢、準備 8 週疫苗	哭鬧常於 6–8 週達高峰；MenB 後撲熱息痛計劃
第 2–3 個月	8、12 週疫苗；互動、抬頭、短段 tummy time	仍要每一覺同房分床；car seat 只用於交通
第 3–4 個月	可能開始翻身；12、16 週疫苗	一有翻身跡象即停包被；任何高處一秒都唔可以離手
第 4–5 個月	增加地墊活動、雙向轉頭、預備家居防護	唔好因夜醒或咬拳就提早加固
第 5–6 個月	睇齊三個加固準備訊號；學杯；食物窒息預防	約 6 個月先開始；直坐、全程看顧、致敏食物逐樣



圖 2 / 0-6 個月主要檢查、疫苗同技能里程碑（按實際出生日期計）。

第 1 章 | 出世後 0-2 小時：先穩定，再相識

1.1 產房即刻會做咩

- 醫護會評估呼吸、心率、膚色、肌張力同反應；需要時先處理呼吸及保暖。
- 情況穩定就盡早肌膚接觸（skin-to-skin）：BB 只着尿片、直放喺照顧者赤裸胸口，頭轉側、鼻口清楚可見，以暖毛巾／毯蓋背部。清醒成人全程望住。
- 肌膚接觸有助保暖、穩定心跳呼吸、嗅覺尋乳同親子連結；剖腹產或需要治療亦可以遲少少做。唔係『錯過黃金一小時就無效』。
- 如果照顧者想瞓、服過鎮靜止痛藥、暈、無力，立即交 BB 畀另一位清醒成人或放回獨立睡眠空間。

立即 | 肌膚接觸都要防意外

BB 下巴唔可以貼胸、頸部唔可以過度屈曲；鼻口必須外露。成人瞓着前一定要將 BB 放回 cot／Moses basket。梳化或扶手椅抱住 BB 瞓着係極高窒息風險。

1.2 第一次餵奶

好多 BB 會喺出生後第一小時表現覓食：轉頭、舔唇、伸舌、手到口、蠕動。哭係較遲嘅飢餓訊號；等到大哭先餵，BB 會較難含乳。母乳初乳（colostrum）量少但濃縮，正常係頻密、少量。若選配方奶，醫護會按 BB 情況協助。

- 母乳：鼻尖對乳頭，等嘴巴張大先將 BB 靠近；下巴先貼乳房，鼻孔仍可呼吸。初幾啖可有拉扯感，但持續尖痛、乳頭扁／損、啜啜聲多、面頰凹入，應請 midwife 即場睇一次完整餵奶。
- 配方奶：用 first infant formula；唔需要 follow-on formula。唔好自行用『防敏』、『comfort』或稠化奶，除非醫護建議。

- 任何餵法都用 responsive feeding：見早期訊號就餵，見 BB 轉頭、放鬆手、停止吸嘅就停；唔迫清樽。

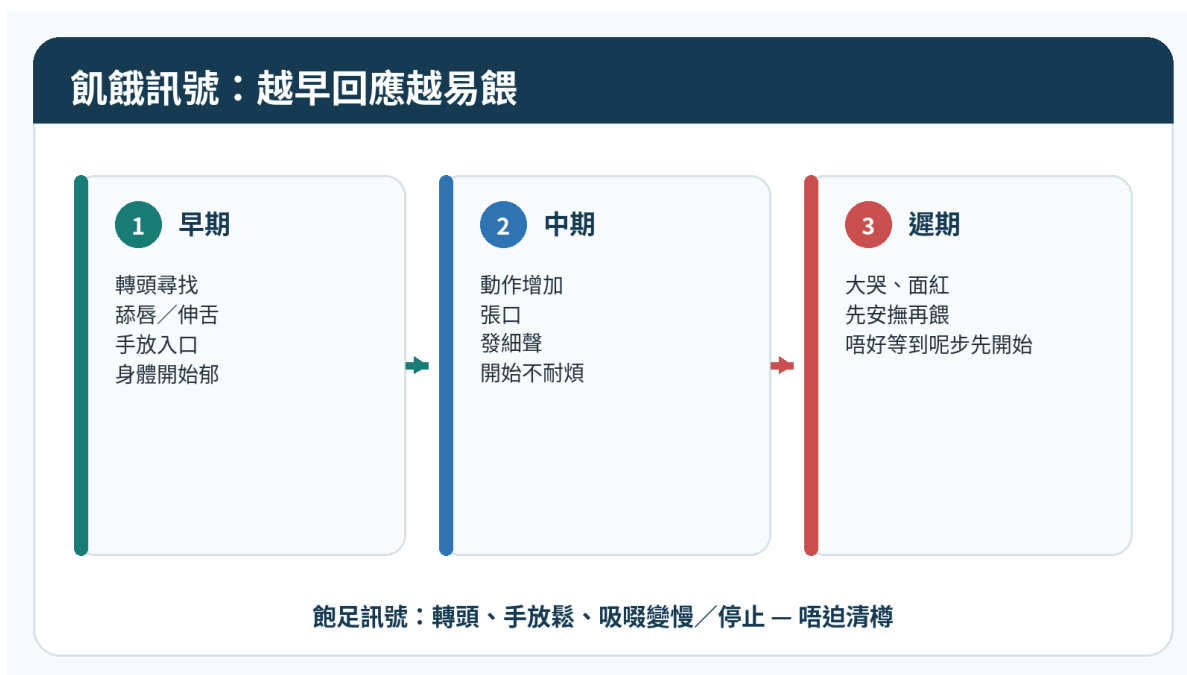


圖 3 | 早期、中期、遲期飢餓訊號；盡量喺哭之前開始餵。

1.3 維他命 K 同基本選擇

醫院通常會喺出生後第一日提供維他命 K，預防罕見但可以致命嘅維他命 K 缺乏性出血。肌肉注射一般一次完成；口服方案需要多次，保護可能較低。醫護會解釋並取得同意。若拒絕或延遲，必須清楚知道後續安排同出血警號。

緊急 | 不正常出血

臍帶、口鼻、針口持續出血；大便有血或黑便（胎糞期除外）；無原因瘀傷、異常嗜睡或抽搐，立即求醫。

1.4 有風險因素嘅 BB：出院前確認特別疫苗

- 若生產者在孕期驗出 hepatitis B：BB 應在出生 24 小時內有單價乙肝疫苗，部分 BB 同時需要 HBIG；4 週再有單價乙肝疫苗，之後接 8、12、16 週常規 6-in-1，18 個月再按專案完成。出院紙要寫清楚日期同負責團隊。
- 若父母／祖父母來自 TB 高風險地區、BB 將長住高風險地區或有密切 TB 接觸，可能合資格 BCG。現行做法多在約 28 日、等 newborn blood spot 的 SCID 結果後接種。
- 上述屬選擇性／暴露後路徑，常規 6-in-1 本身含乙肝，但唔可以取代出生後 24 小時嗰劑。未確定資格就出院前問 midwife，並在 red book 記錄。

第 2 章 | 第 1 日：第一次完整 24 小時

2.1 新生兒身體檢查同篩查時間

項目	通常時間	重點
NIPE 新生兒身體檢查	出生後 72 小時內；6-8 週再做	眼睛、心臟、髖關節；男嬰睪丸等
聽力篩查	多數出院前；應於 4 週內，最遲 3 個月	第一次未通過唔等於聽力損失，會安排覆檢
Blood spot／heel-prick	通常第 5 日	腳跟取少量血，篩查 10 種罕見但嚴重疾病；結果通常 6 週內
體重	出生、頭 2 週按需要	最初減重常見；多數約 3 週回復出生體重

保留 Personal Child Health Record (PCHR／red book)，將餵奶、濕片、體重、疫苗、藥物反應同問題寫低。去任何診症或疫苗預約都帶埋。

2.2 第一次尿同胎糞

胎糞 (meconium) 係黑綠色、黏身，通常 24 小時內排出。尿片可能見橙粉紅色尿酸鹽結晶，頭幾日少量可以出現；但若持續、尿量少或 BB 食得差，要同 midwife 講。

緊急 | 第 1 日要即日報告

24 小時仍未有濕片或未排胎糞；腹脹、反覆嘔吐，尤其綠色；食唔到、很難喚醒；呼吸快／呻吟；體溫異常。

2.3 常見外觀：邊啲通常會自己退

可見變化	通常情況	要問醫護
頭形／頭皮腫	產道壓力可令頭形暫時拉長；多數幾日改善	腫塊增大、BB 很痛、蒼白／嗜睡，或你唔肯定
白色小點／紅斑	Milia、erythema toxicum 常見，唔搽藥、唔擠	起水泡、膿、合併發燒或精神差
乳房腫、女嬰白帶／少量血	受孕期荷爾蒙影響，可短暫出現；唔擠乳房	紅熱痛、膿、持續大量出血
前囟（頭頂軟位）	輕微隨脈搏郁可正常	安靜直抱仍明顯凸、或凹陷兼尿少／精神差

2.4 第一晚安全睡眠

- 每一覺都仰睡（on the back），包括日睡。側睡同俯睡都唔安全。
- BB 自己嘅 cot／Moses basket，放喺照顧者同一房至少首 6 個月；床褥要平、實、合尺寸、有防水層。
- 清空睡眠空間：無枕頭、被胎、床圍、軟玩具、羊毛墊、窩／pod、楔形墊、定位器、加重睡袋或監測枕。
- 用貼身合碼睡袋，或 BB 雙腳放床尾、薄毯牢固攝於腋下以下；頭面外露。室溫 16–20°C；摸胸口／後頸判斷，手腳偏涼可以正常。
- BB 喺 car seat、swing、bouncer 或 sling 瞓着：到達目的地後盡快移去平實床褥。

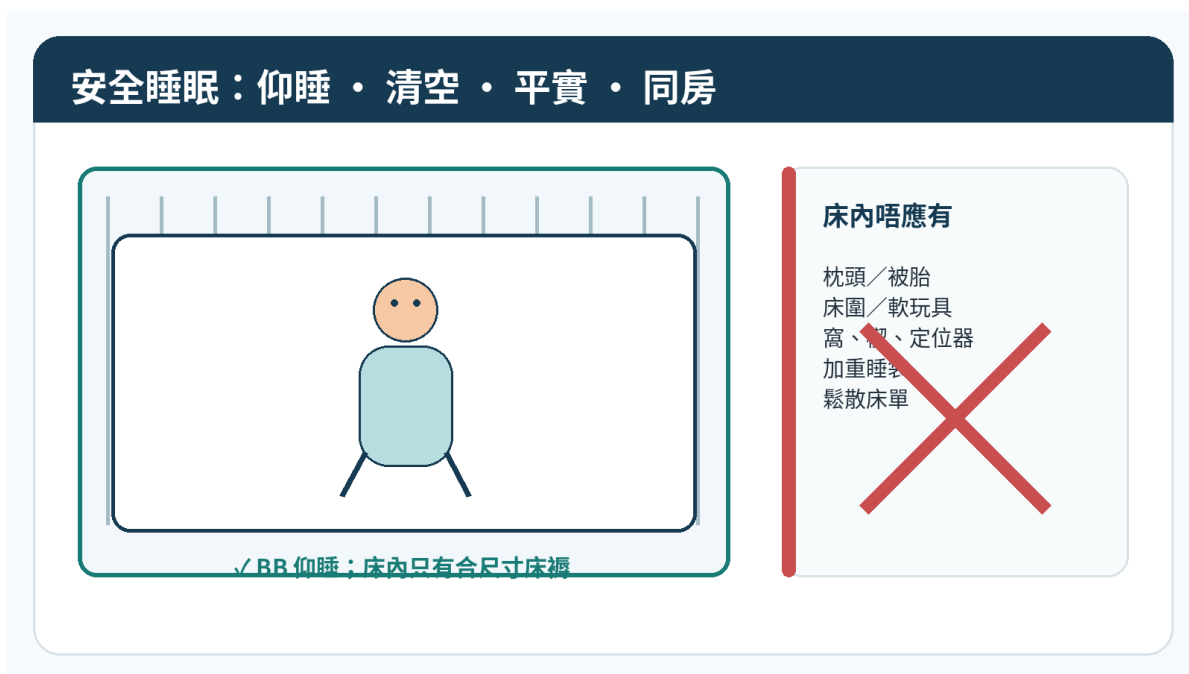


圖 4 / 安全睡眠：仰睡、同房分床、平實清空。

立即 | 永遠唔好喺梳化／扶手椅同 BB 一齊瞓

呢個情境窒息風險特別高。夜晚餵奶前先設計一個安全回床流程；如果覺得自己會瞓着，叫醒另一位成人接手。

第 3 章 | 第 2-3 日：奶量建立、黃疸開始出現

3.1 頻密餵係正常，但要睇『有效』

母乳 BB 頭幾星期一般 24 小時至少 8-12 次，亦可能某段每小時都食（cluster feeding）。重點唔係時鐘，而係有吞嚥、餵完較平靜、乳房較軟、尿便逐日增加、體重趨勢合理。需要時要喚醒過度嗜睡或有黃疸嘅 BB 餵。

日齡	濕片最低趨勢	大便趨勢
第 1 日	至少約 1 塊	至少 1 次黑綠胎糞
第 2 日	至少約 2 塊	胎糞，逐漸無咁黏

日齡	濕片最低趨勢	大便趨勢
第 3–4 日	約 3 塊或以上，愈來愈重	每日至少約 2 次，綠／啡轉黃
第 5 日起	通常 ≥ 6 塊重濕片／24 小時	母乳 BB 頭幾週通常每日 ≥ 2 次柔軟黃色便；配方奶便較實、較深色

呢張表係趨勢工具，唔係用一塊尿片判斷。大便頻率其後可改變；但新生期排便少、尿量跌、口乾、無眼淚、前囟凹或精神差，要評估餵食同脫水。



圖 5 | 頭一星期尿片同便便顏色轉變。數量突然下降比單一顏色更重要。

3.2 黃疸：常見，但時間同狀態決定危險度

黃疸係皮膚同眼白變黃，通常出生後第 2–3 日開始。喺自然光觀察，輕按鼻尖／胸口再放手；深色皮膚可較易喺眼白、牙肉、手掌腳掌見到。單靠相片或視覺唔足夠，懷疑就由醫護量度 bilirubin。

立即 | 首 24 小時出現黃疸 = 緊急

立即通知醫院／midwife；唔好等第二日。

緊急 | 黃疸需即日評估

顏色快速加深或落到腳；BB 很難喚醒、食得差、尖聲哭；尿深色而尿片唔係淡色、便便白／灰／粉筆色；足月 BB 超過 14 日仍黃（早產超過 21 日）。

- 繼續有效餵奶：母乳通常 8–12 次／日；按醫護指示叫醒餵。
- 唔好用陽光『照退黃』，亦唔好自行餵水或葡萄糖水；需要光療會用醫療設備。
- 如果奶未上、含乳痛、BB 吞嚥少或濕片不足，同日搵 feeding support。

第 4 章 | 第 3–7 日：出院後基本功

4.1 臍帶：乾、清潔、唔搽嘢

- 摺低尿片前沿，避免磨擦同浸尿；保持乾爽。
- 如果被尿便整污，用清水清潔，再輕拍乾；平時唔需要酒精、爽身粉、藥油或草藥。
- 殘端多數約 5–12 日脫落；脫落時一點點血可以見到，唔好扯。

緊急 | 臍炎警號

皮膚紅腫向外擴散、發熱、惡臭膿液、持續出血，或 BB 發燒／食得差／精神差，立即求醫。

4.2 洗面、抹身、第一次沖涼

BB 唔需要每日沖涼；頭一個月清水已足夠。可以 top-and-tail：每日按需要洗面、頸摺、手、臀部。胎脂（vernix）可留嚟皮膚自然吸收。避免香料、精油、爽身粉、成人濕紙巾同未經建議嘅藥膏。

1. 先準備毛巾、乾淨衫、尿片；關窗保暖，手機放低。
2. 先放凍水再加熱水，混勻；約 37–38°C，以手腕／手肘試暖而唔燙。水深約 5–10 cm 已夠。
3. 一手由 BB 背後托住遠側上臂，前臂托頭頸；另一手清洗。頭面保持水上。
4. 5–10 分鐘內完成，立即包暖，特別拍乾頸、腋、腹股溝摺位。

立即 | 水邊一秒都唔可以離手

如果漏咗嘢，抱 BB 一齊離開；唔可以叫年長小朋友睇住。沖涼橈、bath seat 都唔係安全替代。

沖涼托抱：一隻手固定頭頸與上臂

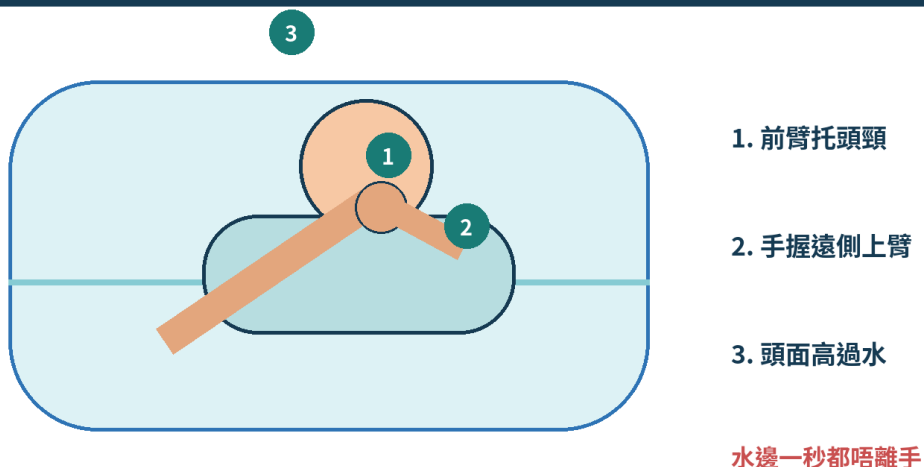


圖 6 | 沖涼托抱：手臂托頭頸、手握遠側上臂，頭面永遠高過水。

4.3 換片同尿布疹

- 最好喺地上換片墊換；床、梳化、換片枱一秒都唔好離手。
- 女嬰由前向後抹；男嬰清潔陰莖外面同陰囊周圍，唔好強行翻開包皮。
- 用清水／無香料棉或濕巾，輕拍乾；有紅疹可薄搽 barrier cream。保持乾爽、勤換片。

- 成片鮮紅、摺位都紅、有衛星小點、起泡、流膿、發燒，或 2-3 日無改善，問 pharmacist／GP。

4.4 第 5 日 blood spot

通常由 midwife 喺第 5 日做 heel-prick。餵奶／肌膚接觸可幫 BB 安定。記低完成日期；如果錯過或樣本要重抽，盡快跟進。篩查唔係診斷，異常結果會由專業團隊聯絡。

第 5 章 | 第 1-2 週：確認食得夠、建立支援網

5.1 體重同餵食覆核

出生後減重常見，但百分比、臨床狀態同回升速度要一齊睇。多數 BB 約 3 週回復出生體重；唔好自己用成人磅頻密秤。若醫護話減重較多、濕片不足、BB 食住瞓或母乳持續痛，應做一次面對面完整餵食評估，必要時訂補充／擠奶計劃。

緊急 | 食得唔夠嘅組合警號

第 5 日後少於約 6 塊重濕片、尿色深、口乾、前囟凹、持續嗜睡、黃疸加深、餵極無吞嚥或體重繼續明顯跌。任何幾項一齊出現要同日求助。

5.2 Midwife、health visitor、GP

- 社區 midwife 通常照顧至約第 10 日（需要時可延長），之後交接 health visitor。
- health visitor 通常約 10-14 日做 new-baby review，傾餵奶、體重、安全睡眠、親子關係、家居安全同照顧者情緒。
- 盡早為 BB 註冊 GP。未完成註冊都可以得到緊急治療，唔好因此延誤。
- 聽力篩查若未完成，要確保 4 週內有安排。保留 red book。

5.3 訪客、洗手、唇瘡

- 所有人抱 BB 前用肥皂洗手；病咗、發燒、傷風、肚瀉嘅訪客改期。
- 出生首 6 週對 herpes 特別脆弱。任何現有或近期唇瘡、口唇刺痛、手指疱疹或身上水泡嘅人唔可以吻 BB；最好避免接觸。
- 即使無唇瘡，非主要照顧者唔吻 BB；主要照顧者最安全只吻頭頂，避開口、鼻、眼。
- 乳房／乳頭附近有 herpes 水泡：唔好用該邊餵或用該邊擠出奶，立即問醫護；另一邊通常仍可餵，但需嚴格洗手同遮蓋病灶。

緊急 | 新生兒 herpes 可無水泡

若 BB 接觸唇瘡後出現食差、難安撫、38°C 或以上、皮膚／眼／口瘡，立即 call GP／111；若軟癱、難喚醒、呼吸困難、抽搐，call 999。

5.4 維他命 D

由出生開始：全母乳或每日配方奶少於 500 ml 嘅 BB，一般每日 8.5–10 微克 (µg) 維他命 D。每日飲至少 500 ml 配方奶通常唔需另補，因配方已添加。選嬰兒合適產品，用隨附滴管按標籤；唔好將多種維他命重複疊加。早產／有病 BB 依醫院處方。

第 6 章 | 第 3–4 週：哭鬧、睡眠同清醒活動

6.1 睡眠係碎片化，唔係『教壞』

新生 BB 24 小時總睡眠可以約 8–18 小時，差異好大，通常一段段瞓並因餵奶醒。唔需要追求『瞓過夜』；先確保有效餵食、體重同安全睡眠。日間開窗簾、正常家居聲、短互動；夜晚燈暗、動作慢、少刺激，係溫和日夜提示。

- 每次放床：仰睡、清空、平實、同房。
- 覺得眼瞓就唔好抱住坐梳化；預先安排輪班同『安全放低 BB』位置。

- 唔需要用 app 規定每段 nap；睇打呵欠、望開、動作凌亂等疲倦訊號。過劫反而更難安定。

6.2 哭鬧高峰前要有計劃：ICON

嬰兒哭鬧通常由約 2 週增加，約 6–8 週達高峰，再慢慢下降。先檢查：餓、片、太熱／冷、想抱、過度刺激、打嗝／不適、病徵。可以肌膚接觸、輕搖、行動、白噪音低聲、抱抱（未有翻身跡象且遵守安全規則）。

ICON	做法
I — Infant crying is normal	哭係正常溝通；唔代表你失敗
C — Comforting methods	逐樣試，唔需不停轉方法
O — It is OK to walk away	BB 仰睡放入清空 cot，離開幾分鐘冷靜，定時回看
N — Never, ever shake	永遠唔搖 BB；搖晃可致腦損傷或死亡

立即 | 頂唔順嗰刻點做

安全放低 BB → 離房幾分鐘 → 深呼吸／飲水 → call 另一位成人接手。若擔心自己會傷害 BB，立即遠離、叫人接手並求助 111／999。

緊急 | 唔似平時嘅哭

持續尖銳／微弱哭、無法安撫兼食差、發燒、呼吸異常、腹脹、反覆嘔、皮疹、軟癱或難喚醒，要即日甚至緊急評估。

6.3 Tummy time 由出生起，但只限清醒看顧

- 由照顧者胸口開始：你完全清醒、身體略後傾，BB 俯臥胸前，鼻口清楚。
- 之後轉到地墊，短而密：例如每次 1–2 分鐘，一日多次；BB 狀態好先逐步延長。唔以哭住完成為目標。
- 用自己塊面、黑白圖卡或玩具吸引左右轉頭；亦可側臥玩、直抱，減少後腦持續受壓。

- 一瞓着即轉仰睡入床。Tummy time 永遠唔係睡姿。

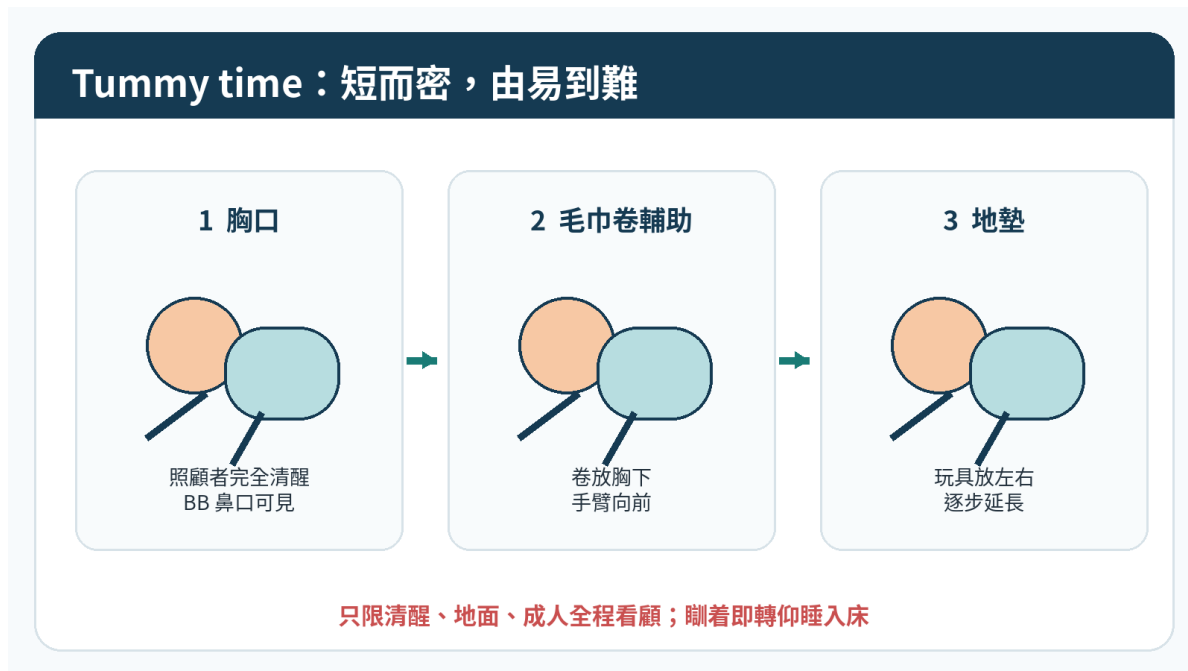


圖 7 / Tummy time 進階：胸口 → 毛巾卷輔助 → 地墊；全程清醒看顧。

第 7 章 | 第 5-8 週：覆檢、疫苗、哭鬧高峰

7.1 6-8 週 GP 檢查

GP 會再檢查心臟、眼睛、髕關節；男嬰會檢查睪丸，亦會問餵食、發展同照顧者健康。預先喺 red book 寫低：有無偏頭、含乳痛、嘔吐、便便異常、濕疹、呼吸聲、聽聲反應、你嘅情緒同睡眠。任何『技能倒退』或 BB 永遠偏向一邊，都要提出。

7.2 8 週疫苗（英格蘭 2026 時間表）

疫苗	保護疾病	常見反應／特別提醒
6-in-1 第 1 劑	白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、Hib、乙肝	針口痛、煩躁、發燒
Rotavirus 第 1 劑（口服）	輪狀病毒腸胃炎	短暫肚瀉／煩躁；換片後仔細洗手約 2 週

疫苗	保護疾病	常見反應／特別提醒
MenB 第 1 劑	B 型腦膜炎雙球菌	較常發燒；按 UKHSA 指示預防性 infant paracetamol

緊急 | MenB 後撲熱息痛：只用正確濃度

現行 UKHSA 指引：infant paracetamol 120 mg/5 ml，每次 2.5 ml；打針後盡快第 1 劑，4–6 小時後第 2 劑，再 4–6 小時後第 3 劑；兩劑至少隔 4 小時，24 小時不超過 4 劑。一定核對樽身濃度、診所指示同 BB 情況；早產、體重特別低或醫護另有指示者先問。唔好用成人配方，唔好憑普通茶匙。

- 預約前：帶 red book；話畀護士知發燒、嚴重病、過往疫苗反應或藥物問題。輕微傷風一般未必需延遲，由護士判斷。
- 打針後：正常餵奶、肌膚接觸、留意呼吸、反應、濕片。唔好為退燒脫光／冷水抹身。
- Rotavirus 後一星期內如陣發性劇哭、屈腳、反覆嘔、血／啫喱樣便或異常嗜睡，急症評估；屬罕見腸套疊警號。

7.3 包被 swaddle：開始準備停止

如果用包被，只可薄料、肩以下、髖腿可屈曲張開、頭面外露、仰睡；唔可同床、發燒或感染時用。BB 一有側滾、扭身似想翻身嘅跡象就立即停，唔係等到第一次成功翻身先停。睡袋通常較簡單。

第 8 章 | 第 2–3 個月：互動增加，安全規則不變

8.1 日常節奏

- 餵：繼續按訊號。生長突增時幾日內食密咗可以正常；仍要用吞嚥、濕片、精神、體重判斷。
- 瞓：仍然每一覺仰睡、清空 cot、同房分床。部分 3–6 個月 BB 夜間段落變長，但唔係人人。

- 玩：面對面講嘢、模仿聲音、唱歌、讀簡單圖書；短段 tummy time 累積。BB 望開係要休息，唔好追住刺激。
- 抱：轉換左右邊餵同抱，玩具左右移動；減少長時間困喺 car seat／bouncer，幫助頭形同動作。

8.2 12 週疫苗

疫苗	劑次
6-in-1	第 2 劑
MenB	第 2 劑；同樣按 UKHSA 指示使用 3 劑 infant paracetamol
Rotavirus	第 2 劑；完成嬰兒課程，需按年齡時限接種

疫苗時間表會更新；診所通知同 NHS 當時頁面為準。漏咗預約通常可以追針，唔好因遲咗而放棄，盡快聯絡 GP。

8.3 Reflux 同嘔奶：睇 BB 狀態，唔只睇污糟程度

少量奶由口角流出、BB 仍開心、增重同濕片正常，常見。餵時保持半直、慢流量、容許停頓；餵後直抱一陣但照顧者要清醒。睡眠仍然仰睡平床，唔墊高床頭、唔側睡、唔用楔墊。

立即 | 嘔吐紅旗

綠色膽汁樣、吐血、腹脹兼痛、BB 軟／難喚醒，立即 999/A&E。反覆噴射式嘔吐、食唔到、濕片少、體重差或嘔吐物啡黑，要同日評估。

第 9 章 | 第 3-4 個月：開始翻身，環境要升級

9.1 一見翻身跡象，三件事即改

1. 立即停包被；轉用手臂自由、合身睡袋。
2. 換片盡量地上做；任何床、梳化、枱都當 BB 隨時會跌。
3. 地墊活動範圍清走細物、膠袋、線、熱飲、寵物；高椅／嬰兒車每次扣 5 點式安全帶。

每次仍然由成人放 BB 仰睡。若 BB 已能自己由背轉肚、亦能由肚轉背，可讓佢自行選擇睡姿；唔需要成晚反覆翻返，但床必須完全清空。未能雙向翻身時見到俯臥，可輕輕轉回仰睡。

做法 | 扁頭預防唔可以犧牲安全睡眠

睡覺永遠仰睡；清醒時增加 tummy time、左右抱餵、改玩具位置、少困 car seat。唔好用枕頭或睡眠定位器。若頭永遠側向同一邊、轉頸困難或頭形令你擔心，見 GP／health visitor。

9.2 16 週疫苗

疫苗	劑次／備註
6-in-1	第 3 劑
PCV (pneumococcal)	第 1 劑

現行時間表 16 週唔再係舊資料常見嘅 MenB／MenC 組合；以 NHS 2026 表為準。打針後若 BB 反應異常、呼吸困難、面唇腫或無反應，999。

第 10 章 | 第 4-5 個月：地面活動、出街同預備家居

10.1 發展唔係考試

呢段時間常見對人笑、發更多聲、手到口、追視、抬頭穩定啲、嘗試翻身；每個 BB 次序同速度唔同。重點係整體有進步、左右較對稱、對聲／人有反應。唔好用社交媒體影片比賽。任何已學識技能倒退、突然一邊無力、持續鬆軟／過硬、對大聲無反應或你持續擔心，盡早同 health visitor／GP 傾。

每日活動	做法	安全界線
Tummy time	短段多次，玩具放前方及左右	清醒、地面、全程看顧
側臥玩	背後用你隻手支援，雙手喺身前玩	唔用枕固定、唔當睡姿
抱住看世界	左右手輪換，頭頸按能力支援	唔大力拋高、唔搖
講／唱／讀	等 BB 回聲，再回應，形成來回對話	見望開、打呵欠就減刺激

10.2 Sling／carrier：TICKS

字母	檢查
T — Tight	貼身穩固，BB 唔會縮入布袋
I — In view	任何時候見到整塊面
C — Close enough to kiss	低頭可吻頭頂
K — Keep chin off chest	下巴離胸，頸唔屈曲堵氣道
S — Supported back	背部自然受支撐，保持較直

立即 | 唔好畀 sling 入面免手扶餵奶

尤其 4 個月以下，氣道窒息風險高。要餵就拎出嚟、用安全姿勢、全程望住。

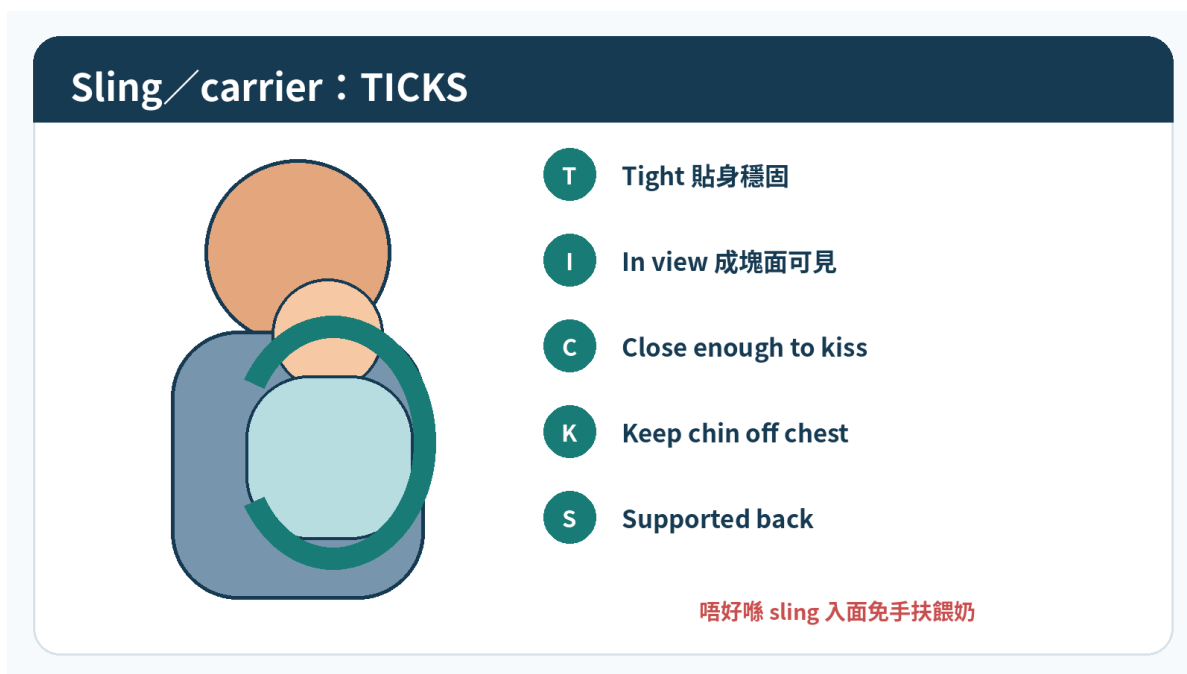


圖 8 / TICKS 五點：面可見、下巴離胸、背部受托。

10.3 Car seat

- 用符合 R129 (i-Size) 或合法標準嘅後向式座椅；R129 至少 15 個月前要後向，實務上可按座椅限制後向更耐。
- 後排通常最安全。後向座椅如放前座，必須關閉前方安全氣袋；按車同座椅說明書安裝。
- 安全帶貼身，肩位正確；厚襖、羽絨、額外墊、非原廠配件唔可以夾喺 BB 同帶之間。
- Car seat 係交通工具，唔係屋企睡床。到達即取出；長途定時停車、取出伸展，並有成人觀察。BB 頭垂胸、呼吸或顏色異常即停車處理。
- 唔買來源不明二手 seat；撞過、裂、零件缺、過期／標籤不清都唔用。

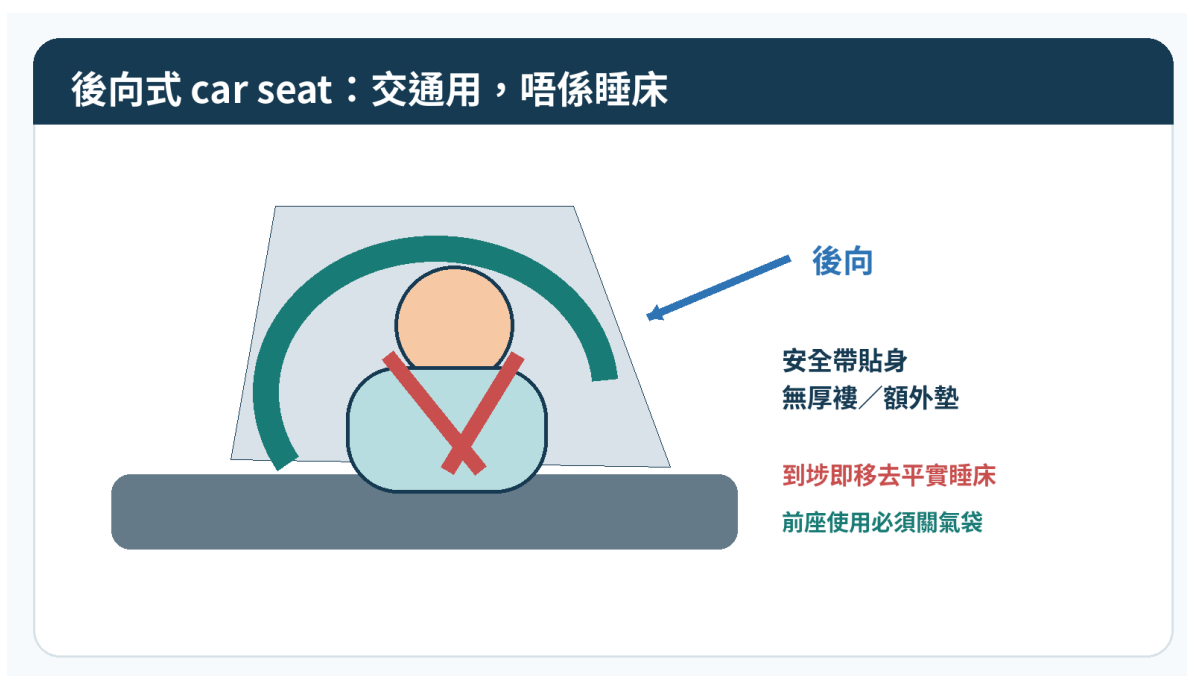


圖 9 / 後向式 car seat：帶貼身、無厚襖、下巴唔壓胸。

第 11 章 | 第 5-6 個月：唔急加固，先睇齊訊號

11.1 約 6 個月先開始，三個訊號要同時有

1. 可保持坐姿並穩定控制頭頸（可有座椅支撐，但唔係成個人塌低）。
2. 眼、手、口協調：見到食物，能伸手拎到並放入口。
3. 能吞嚥食物，而唔係持續用舌推出。

咬拳、夜醒增加、想食多啲奶、睇住大人食，都唔係單獨成熟訊號。提早加固唔會可靠改善睡眠，亦可能增加哽塞／腸胃風險。若早產，用 corrected age 同醫護建議。



圖 10 / 加固三大準備訊號必須一齊出現。

11.2 加固前一週準備清單

- 穩固 highchair、直坐、5 點式安全帶、腳有支撐更易穩定。
- 學過嬰兒哽塞急救；將急救卡貼喺食飯位置。
- 小軟匙、開口杯或無閥 free-flow cup；唔需要餵食網、矽膠咬袋或昂貴機器。
- 家中所有照顧者同意：全程成人近距離看顧、BB 清醒直坐、唔迫住餵、唔塞入口、唔喺車上食。
- 濕疹嚴重、已有食物敏感、曾即時過敏反應或強家族史，開始花生／蛋前問 GP／allergy team。

11.3 口腔同出牙

第一隻牙常約 6 個月出，但早遲都可以。牙一冒出就用細頭軟毛牙刷，每日兩次（睡前最重要），用米粒大小薄薄一抹、至少 1,000 ppm fluoride 牙膏；吐出後唔過水。唔用含糖磨牙啫喱；冷藏（非冰凍）牙膠、乾淨手指按摩牙肉可舒緩。帶 BB 去你嘅牙科覆診熟習環境；英格蘭兒童 NHS 牙科治療免費。

11.4 約 6 個月後嘅維他命

由約 6 個月至 5 歲，NHS 一般建議每日含維他命 A、C、D 嘅補充劑；但每日飲至少 500 ml 配方奶通常唔需另補，因配方已添加。產品濃度不同，按標籤／Healthy Start 或 health visitor 指示，避免重複。

第 12 章 | 約 6 個月：安全開始加固

12.1 第一次食：少量、慢、無壓力

1. 選 BB 清醒、唔太餓亦唔太叻時；先保持平常奶餐。
2. 直坐扣帶，食物放匙或讓 BB 自己拎；先 1-2 小匙／幾條軟手指食物，量由 BB 決定。
3. 食物煮熟至可用手指輕易壓爛；手指食物切成成人手指大小長條，讓 BB 握住一端。
4. 跟隨停食訊號：轉頭、閉嘴、推匙、煩躁。唔逗、唔追、唔迫清碗。
5. 餐後可用開口杯／free-flow cup 提供幾啖清水；首年主要飲品仍係母乳或 first infant formula。

12.2 由鐵質同多樣質感開始

- 每日提供含鐵食物：嫩肉碎、魚、蛋、豆、扁豆、強化嬰兒穀物；配維他命 C 食物幫助吸收。
- 蔬菜先唔怕，亦逐漸加入水果、澱粉、全脂無糖乳酪等；由蓉到有小粒／軟手指食物，唔長期只食幼滑糊。
- 母乳／配方奶仍係主要營養；6-12 個月逐步形成餐次，唔需要一開始三餐。

12.3 致敏食物：逐樣、少量、日間

約 6 個月開始，在 BB 健康嘅日間，逐次引入熟蛋、花生、奶、麩質、魚、芝麻等；每次先一種、少量，觀察約 2 小時。耐受後要定期繼續食，而唔係試一次就停幾個月。花生只可用幼滑花生醬稀釋／拌食物，唔可整匙黏稠花生醬或原粒堅果。

立即 | 嚴重過敏反應

嘴唇／舌／喉腫、呼吸困難、持續咳／喘、聲沙、突然蒼白軟癱或無反應：call 999。只得少量局部紅疹亦先停食、記錄相片同時間，問 111／GP；唔好自行再次挑戰。

12.4 Gagging 同 choking 唔同

	Gagging（作嘔反射）	Choking（哽塞）
聲音	通常有聲、咳／作嘔	可能完全無聲，不能咳／哭／呼吸
顏色	可面紅、流眼水	可變藍灰、驚恐或軟
處理	保持冷靜，讓 BB 自己處理；唔伸手盲挖	立即做最多 5 下背拍＋最多 5 下胸推，求援

12.5 一歲前避免／限制

- 蜂蜜：12 個月前完全避免（嬰兒肉毒桿菌風險）。
- 鹽、糖、果汁、汽水、茶、咖啡；唔加 stock cube／gravy 等高鹽調味。
- 原粒堅果、爆谷、硬糖；圓形硬食物要改形：提子／車厘茄縱向切四，香腸縱向切幼條而唔係圓片。
- 未經巴士德消毒奶品、發霉熟成軟芝士、未熟蛋／肉／魚、原隻貝類。按 NHS 食安頁核對。
- 牛奶可約 6 個月起少量入餵，但 12 個月前唔作主要飲品；follow-on formula 無必要。

技能課 A | 餵奶：由訊號到安全操作

A1 母乳含乳檢查

有效含乳／轉奶	需要協助
嘴張大、下唇外翻；下巴貼乳房，鼻可呼吸；上方乳暈通常露得較多	持續尖痛、乳頭餵後扁／白／破損；BB 只含乳頭
開始快吸，之後深而有節奏；見／聽吞嚥；面頰圓	持續咿嗒聲、面頰凹、頻密滑甩、每餐極長但無吞嚥
餵後 BB 較鬆、乳房較軟；尿便、體重趨勢好	嗜睡叫唔醒、濕片不足、黃疸加深、體重問題

乳房脹可先輕柔手擠少量令乳暈軟；乳頭損傷唔應靠『忍』。若乳房紅熱痛、發冷／流感樣，可能 mastitis，繼續按能力排奶並同日問 GP／111；嚴重不適要急評。

A2 安全沖配方奶：每次一樽

1. 洗手；清潔工作面。餵奶器具先徹底洗淨並消毒（至少至 12 個月）。
2. 用新鮮凍水喉水，先開流一陣；水煲至少 1 公升，煲滾。唔用曾煲過嘅水、軟水機水；一般唔建議樽裝水。
3. 煲滾後放涼不超過 30 分鐘，確保沖奶時仍至少 70°C。
4. 依奶粉罐指示，先將準確水量倒入已消毒樽，再用該罐專用平匙加準確奶粉。唔多、唔少、唔壓實。
5. 裝好搖勻；用流動凍水沖樽身或冷水盆降溫，保持樽蓋在；滴手腕測溫。
6. 立即餵。BB 飲過嘅餘奶丟棄；唔留下一餐、唔翻熱、唔用微波爐。



圖 11 | 配方奶六步：洗／消毒 → 新鮮水煲滾 → ≤30 分鐘 → 水先粉後 → 冷卻 → 即餵棄餘。

立即 | 70°C 係殺菌步驟

奶粉唔係無菌。『先用凍水再加粉』、低溫即沖機、預先沖好多樽放檯面，都可能令細菌繁殖。使用配方奶機時，混合奶粉嗰一刻嘅水必須達至少 70°C；只顯示水箱溫度唔等於安全。

A3 消毒三種方法

方法	做法	注意
蒸氣機／微波爐	完全拆件，開口向下，按廠方時間	未用前保持蓋住；小心蒸氣燙傷
冷水消毒液	完全浸沒、無氣泡，至少 30 分鐘	溶液每 24 小時更換；用無菌夾取
煲滾	確認用品可煮，完全浸沒至少 10 分鐘	奶嘴較易損；每次檢查裂損

Dishwasher 可以清洗但唔等於消毒。洗時用專用刷清潔螺紋、奶嘴孔、閥；風乾或消毒後直接組裝，避免用抹布再污染。

A4 Responsive bottle feeding

- BB 半直坐、頭頸同一直線；樽大致水平，只讓奶填滿奶嘴，流速唔好太急。
- 奶嘴輕觸上唇，等 BB 主動張口；食幾啖就放低少少樽讓停頓。
- 見手放鬆、轉頭、推樽、停止吸就停；唔迫清樽。
- 成人全程抱住；永不墊樽、永不留 BB 自己食、永不喺 cot 入面含樽瞓。

A5 擠奶保存（NHS 一般指引）

位置	最長時間／做法
雪櫃 $\leq 4^{\circ}\text{C}$	最長 8 日；唔肯定雪櫃夠凍則 3 日內
雪櫃內冰格	約 2 週
獨立冰櫃 $\leq -18^{\circ}\text{C}$	最長 6 個月
有冰袋保冷袋	最長 24 小時
解凍後／BB 飲過	雪櫃慢解或暖水回溫；唔微波、唔再雪。BB 飲過後 1 小時內用完，餘下丟棄

容器寫日期時間，舊奶先用。先冷卻新擠奶再按 NHS 指引合併；住院／早產 BB 可能有更嚴格規則。

技能課 B | 睡眠：每一覺都做同一套

B1 SAFE 口訣

字母	原則	操作
S	Supine 仰睡	每一覺由成人放背部朝下；俯睡只限清醒 tummy time
A	Alone space 獨立空間	同房但 BB 有自己 cot／Moses basket
F	Firm, flat, free 平實清空	緊貼床褥、無軟物、無斜坡、無定位器
E	Every sleep／Environment	日睡夜睡一樣；無煙，室溫約 $16-20^{\circ}\text{C}$

B2 同床：最安全係自己床；如可能發生，先減風險

立即 | 以下任何一項都唔可以同床

任何人吸煙／孕期曾吸煙；飲酒；用娛樂性藥物；服令嗜睡藥物；極度疲累；BB 早產（<37 週）或出生體重 <2.5 kg；BB 發燒／不適。梳化／扶手椅任何情況都禁止。

- 成人床褥要實平；BB 仰睡，成人枕、被、床單遠離 BB；唔包被。
- 無其他小朋友／寵物；填補唔到嘅牆隙、床欄縫、床邊陷阱代表唔安全。
- 唔留 BB 一個喺成人床；唔將 BB 放兩個成人中間。
- 夜餵前清走 BB 周圍枕被，並設鬧鐘／叫另一位成人；清醒後放返獨立床。

B3 Dummy／奶嘴（可選，唔係必需）

- 母乳餵養可等含乳同供奶穩定，通常約 4 週，再考慮。
- 如果用，日睡夜睡都一致提供；BB 唔要唔迫，瞓着跌出唔需要塞返。
- 唔蘸甜、唔綁繩、唔掛頸、唔加毛公仔；檢查破損。
- 可於 6–12 個月逐步停。

技能課 C | 急救：哽塞同 CPR

立即 | 呢幾頁只係記憶輔助

請所有固定照顧者完成正式嬰兒急救課程。真實事故要開免提跟 999 接線員指示；唔好為咗翻書而延誤。

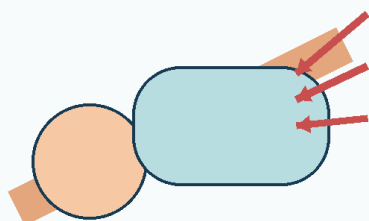
C1 嬰兒哽塞（未滿 1 歲）

如果 BB 能大聲咳／哭／呼吸：鼓勵咳，唔拍背、唔伸手挖。若咳無聲或明顯無效、不能哭／呼吸：

1. 坐或跪穩；BB 面向下伏喺你前臂／大腿，頭低過胸，以手托下顎，唔壓頸。
2. 用掌根喺兩肩胛骨中間最多拍 5 下；每一下後檢查物件有無排出。
3. 仍塞：翻轉面向上、頭仍低；兩指放胸骨下半（乳頭線稍下），最多做 5 下胸推。
4. 背拍 5+ 胸推 5 交替；叫人 call 999，或你用免提求援。
5. 如失去反應：放平實地面，移除口內『清楚見到且容易取出』嘅物件，開始 CPR；唔盲挖。

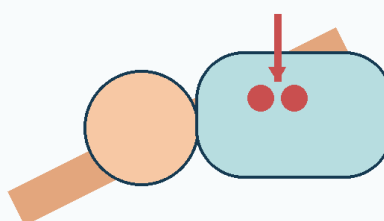
嬰兒哽塞：5 背拍 → 5 胸推

1 | 最多 5 下背拍



面向下、頭低；拍兩肩胛中間

2 | 最多 5 下胸推



面向上、頭低；兩指胸骨下半

每一下後檢查；唔盲挖。無反應就 999+CPR

圖 12 | 嬰兒哽塞：最多 5 下背拍，再最多 5 下胸推；頭低、每下後檢查。

即使物件排出，都要醫療評估，因可能仍有殘留或受傷；尤其做過胸推。

C2 無反應、無正常呼吸：嬰兒 CPR

1. 確保現場安全；輕拍腳底／叫喚，檢查反應。
2. 打開氣道至中立位（嬰兒頭唔好過度後仰）；望、聽、感覺正常呼吸，不超過 10 秒。喘氣唔算正常呼吸。
3. 叫人 call 999、取 AED；如果一個人，用手機免提即刻 call。
4. 做 5 次初始救命呼吸：你個口密封 BB 口同鼻，每次約 1 秒，只吹到胸口明顯升起。若唔升，重新調整頭位同密封，檢查可見阻塞。
5. 做 30 次胸外按壓：胸骨下半，深度至少胸廓三分一（約 4 cm），速度 100–120／分鐘，讓胸廓完全回彈；再 2 次呼吸。持續 30:2。受過兒科 BLS 訓練嘅兩位施救者按課程可用 15:2。

6. 2025 RCUK 建議按壓優先用雙拇指環抱胸廓法；單人空間限制時可用兩指。直至有正常生命徵象、專業人員接手、AED 指示或你無法繼續。

如果你完全獨自一人、身邊無電話可免提求助：先做約 1 分鐘 CPR，之後帶住 BB 去 call 999，再盡快繼續 CPR。

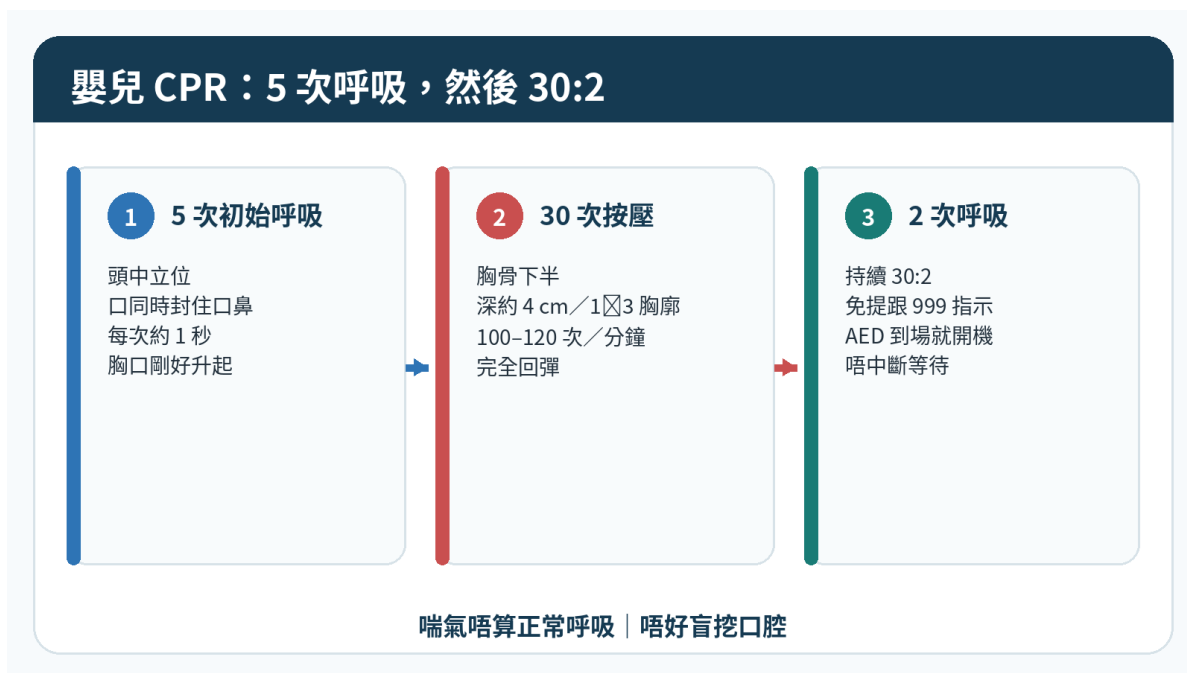


圖 13 | 嬰兒 CPR 記憶圖：5 次初始呼吸；30:2；100-120/min；深約 4 cm。

立即 | AED 可以用於嬰兒

有 pediatric pads / 模式就用；無嘅話按 999 / AED 指示用成人 pads，避免兩塊互相接觸（可一前一後）。唔好因等 AED 而停 CPR。

技能課 D | 常見病徵同紅旗分流

D1 快速觀察五項

觀察	較安心	紅旗
呼吸	安靜、無凹胸、可正常食	呻吟、鼻翼煽動、肋下凹、停頓、藍灰
反應	會望、會郁、可喚醒	難喚醒、軟、異常高音／微弱哭、抽搐
餵食	大致如常、吞嚥	明顯少、食唔到、每餐即喘／出汗／發紫
水分	濕片趨勢穩定、口濕	12 小時無尿、前囟／眼凹、無淚、口乾
顏色／皮疹	接近平常	非褪色疹、藍灰、蒼白斑駁、黃疸迅速加深

D2 正確量體溫

1. 用數碼探熱針；探頭放腋窩頂部。
2. 手臂貼緊身側，按說明書等到提示。
3. 剛沖涼、包得很厚或房間很熱，等幾分鐘再量；但 BB 明顯不適唔好為重測拖延求助。
4. 記錄時間、數字、量度位置、疫苗日期、BB 反應同最後濕片。額貼／單靠摸額唔夠準。

D3 感冒／bronchiolitis

Bronchiolitis 常由流鼻水、咳開始，之後呼吸快、喘／crackle、食得辛苦，往往第 3–5 日最差。細 BB 可快速脫水。少量多餐、保持直抱（清醒時）、鼻塞可問 pharmacist／GP 關於生理鹽水；唔用蒸氣燙、精油、成人鼻藥或非處方咳藥。

立即 | 呼吸紅旗

胸／肋骨下凹、呻吟、長呼吸停頓、嘴舌藍灰、太喘而食唔到、軟或叫唔醒：999。食量少於平常一半、濕片減少、呼吸明顯加快但未到以上程度：111／同日評估。

D4 藥物安全

- Paracetamol：一般 2 個月以下唔畀，除非醫護；MenB 疫苗係特定例外，跟 UKHSA 指示。
- Ibuprofen：3 個月以下或 <5 kg 唔畀；脫水、出水痘亦唔畀；哮喘先問醫護。
- 唔交替 paracetamol/ibuprofen，除非醫護明確指示；永遠核對濃度、體重／年齡同最短間隔。
- 16 歲以下唔用 aspirin，除非專科處方；唔用成人咳藥、成藥、草藥、精油或剩餘抗生素。
- 用口服針筒，唔用廚房茶匙；每次記錄藥名、濃度、ml、時間同畀藥人。藥鎖高、過期交藥房。

技能課 E | 家居、外出同產品安全

E1 由 BB 未識郁開始防意外

風險	立即做
跌落	地上換片；bouncer/car seat 只放地，唔放枱；抱 BB 行樓梯要一手扶欄、路面清
窒息	尿片袋／膠袋收高兼離 cot；細物、硬幣、鈕、玩具零件遠離地面活動區
勒頸	窗簾／百葉簾繩固定收高；唔用 dummy 繩、頸鏈、琥珀鏈、hoodie 索繩
燙傷	熱飲放遠離枱邊；抱 BB 時唔飲熱飲／煮食；先凍水後熱水，混勻先落浴
中毒／灼傷	藥、洗衣膠囊、清潔劑鎖起；鈕扣電池同磁石一粒都可致命，疑吞立即 A&E／999
火／煙	家居無煙；每層裝煙霧警報，燃氣／固體燃料環境裝 CO 警報並定期測試
寵物	BB 同任何狗／貓永不單獨相處；寵物唔入 cot，給寵物自己安靜空間

E2 睡眠／育兒產品購買原則

- Cot 符合 BS EN 716；欄距不超過約 6.5 cm；床褥合尺寸、平實、防水，最好新買或確知歷史。
- 產品寫『透氣』、『防扁頭』、『防 reflux』、『監測呼吸』唔代表能預防 SIDS。無醫療需要嘅家用監測器唔取代安全睡眠或人工觀察。

- 二手：cot 框可按狀況，但床褥、car seat 尤其要慎重；召回、裂損、缺說明、來源不明就唔用。
- 睡袋：頸／袖口合身，BB 唔會滑入；按房溫同廠方 tog 指引，唔再加被或厚衣。

E3 太陽同炎熱天氣

- 6 個月以下避開直射陽光；用 pram sunshade／parasol、輕薄衣帽。唔用毯或 muslin 蓋住 pram，會困熱。
- 全母乳 BB 0–6 個月熱天可增加母乳次數，通常唔需要水。配方奶 BB 可在正常奶餐外少量 cooled boiled water，但先按 NHS／health visitor 個別建議；絕不能稀釋配方奶。
- 停泊車廂一分鐘都唔留 BB；定時摸胸／後頸，出汗、胸口很熱就減衣、移到涼處。
- 約 6 個月起如暴露，可用 SPF ≥30、同時 UVA/UVB 防護嘅嬰幼兒防曬，足量每 2 小時補；但遮蔭、衣帽仍為主。

技能課 F | 照顧者身心：BB 安全嘅一部分

F1 輪班唔係奢侈，係風險控制

- 每日講清楚『邊個當值』；當值者唔飲酒、唔用令人嗜睡藥物後獨自照顧。
- 夜更準備水、簡單食物、已充電電話、乾淨奶具／尿片，但睡眠空間維持清空。
- 每位照顧者至少有一段受保護睡眠；極度眼瞓就先放 BB 入安全 cot，再處理其他事。
- 訪客最有用係煮飯、洗衫、買餸、睇住 BB 俾主要照顧者沖涼／瞓，而唔係要求招呼。

F2 Baby blues、產後抑鬱、產後思覺失調

頭幾日易喊、焦慮、情緒波動可以係 baby blues，通常兩週內改善。低落／焦慮持續超過兩週、愈來愈重、無法享受、覺得無望、難與 BB 連結或無法休息，即使只得部分症狀，都同 GP／midwife／health visitor 講。爸爸／伴侶亦可有產後抑鬱。

立即 | 思想混亂或傷害念頭＝唔好一個人承受

聽到／見到不存在嘅事、妄想、極端興奮／混亂、幾乎唔瞓、或有傷害自己／BB／他人嘅念頭：立即確保另一位清醒成人接手 BB，call 999 或要求同日緊急精神健康評估。Postpartum psychosis 係醫療急症，可以快速惡化，亦可治療。

F3 產後身體紅旗

立即 | 生產者需要緊急醫療

突然／大量出血兼暈；胸痛或呼吸困難；抽搐；突然劇烈頭痛、視力改變；單邊小腿紅腫痛；發燒發冷兼肚痛／惡臭分泌；傷口快速紅腫；立即求助，嚴重者 999。照顧自己就係保護 BB。

實用附錄 1 | 每個月一頁檢查清單

出世至第 7 日

- ☐ 每覺仰睡、同房分床、清空平實；☐ 成人唔喺梳化抱睡；☐ 每日記餵奶／尿便；
- ☐ 完成維他命 K 選擇、NIPE 安排；☐ 第 5 日 heel-prick；☐ 聽力篩查安排；
- ☐ 掌握早期飢餓訊號；配方奶照 70°C 流程；☐ 濕片逐日增加，第 5 日起通常 ≥6 重濕片；
- ☐ 首 24 小時黃疸、無胎糞／尿、綠嘔、發燒、難喚醒即求助。

第 2-4 週

- ☐ Health visitor new-baby review；☐ GP 註冊；☐ 追聽力／blood spot 結果；
- ☐ 每日維他命 D（母乳或 <500 ml formula）；☐ 臍帶乾燥，紅腫／膿即求助；
- ☐ Tummy time 短而密；☐ ICON 計劃貼牆；☐ 兩位照顧者輪班避免瞓着抱 BB；
- ☐ 任何訪客洗手，病／唇瘡唔接觸或吻 BB。

第 5-8 週

- ☐ 預約 6-8 週 GP 檢查；☐ 8 週疫苗；☐ 買啱 120 mg/5 ml infant paracetamol 並核對診所指示；
- ☐ 哭鬧高峰照 ICON；☐ 有翻身跡象停包被；☐ 每覺仍同房分床；
- ☐ 記錄偏頭／頭形、餵食痛、濕片、反應；有疑問帶 red book 問。

第 2-4 個月

- ☐ 12 週、16 週疫苗；☐ 地墊活動增加；☐ 轉換抱餵方向；☐ car seat 到埗即取出；
- ☐ 翻身後睡床完全清空；☐ 高處不離手；☐ 細物、膠袋、線、熱飲清離活動區；
- ☐ 每日講、唱、讀、等 BB 回應；☐ 技能倒退／不對稱／無聲音反應就求助。

第 5-6 個月

- ☐ 家居 crawl-proof ; ☐ highchair 5 點式帶 ; ☐ 全家識 choking 急救 ;
- ☐ 加固三訊號齊先開始 ; ☐ 奶仍主食 ; ☐ 鐵質食物 ; ☐ 致敏食物逐樣日間引入並持續 ;
- ☐ 蜂蜜、整粒堅果、硬圓食物、鹽糖避免 ; ☐ 第一隻牙即用 $\geq 1,000$ ppm fluoride 牙膏薄抹刷兩次。

實用附錄 2 | 疫苗日曆（英格蘭現行）

月齡	疫苗
出生／4 週（只限特定風險）	生產者有乙肝：單價乙肝疫苗出生 24 小時內及 4 週；部分需 HBIG。TB 高風險 BB：約 28 日 BCG
8 週	6-in-1 第 1 劑、Rotavirus 第 1 劑、MenB 第 1 劑
12 週	6-in-1 第 2 劑、MenB 第 2 劑、Rotavirus 第 2 劑
16 週	6-in-1 第 3 劑、PCV 第 1 劑
1 歲（預告）	MMRV 第 1 劑（2025-01-01 起出生兒童）、PCV 第 2 劑、MenB 第 3 劑

日期用實際出生日起計，而唔係預產期。診所會約期；若早產，常仍按實際出生年月接種，但由新生兒／GP 團隊確認。本文完成時距離實際接種可能有數月，出發前再核對 NHS 最新時間表。

疫苗後記錄格

日期／疫苗	體溫與時間	藥名、濃度、ml、時間	餵食／濕片／其他反應

實用附錄 3 | Nuneaton / Warwickshire 求助頁

本地 | 先用全國分流

生命危險：999。急需判斷：NHS 111（嬰兒建議打電話）。日常／即日問題：自己 GP、community midwife 或 health visitor。電話同服務時間可改，使用前以官方網站／red book 最新資料為準。

服務	2026-08 查核資料	用途
George Eliot Hospital Maternity	Community Midwives：024 7686 5022	產前／產後助產服務；以出院資料嘅 24 小時聯絡方法為先
Warwickshire Health Visiting 0-5	0300 247 0072（週一至五 9:00-17:00）； ChatHealth 07520 615293	餵食、成長、發展、睡眠、家居、照顧者支援；非急症
Hatters Space Best Start Family Hub	Upper Abbey Street, Nuneaton CV11 5DN；024 7638 4491	家庭支援、活動、轉介；先查當日時間表
George Eliot Hospital UTC	College Street, Nuneaton CV10 7DJ	非生命危險急症；先經 111 分流可減少去錯服務

去診症帶：red book、尿片／餵奶記錄、藥物樽或相片、探熱時間、疫苗日期、嘔吐／便便／皮疹相片（如安全做到）、BB 常用奶同尿片。若情況轉差，立即通知候診區職員。

實用附錄 4 | 可打印記錄表

24 小時餵食與尿片

時間	母乳（邊／分鐘）或配方 ml	吞嚥／反應	尿	便（顏色／質地）	備註

醫療求助前 SBAR 小抄

SBAR	要講咩
S — Situation	BB 幾大、最擔心咩、由幾時開始
B — Background	出生週數／體重、病史、餵法、最近疫苗／接觸
A — Assessment	體溫、呼吸、顏色、反應、食量、最後濕片、嘔／便／疹
R — Request	我需要即刻去 A&E 嗎？下一步做咩？幾耐無改善要再求助？

照顧者交更清單

- ☐ 上次食奶時間／量；☐ 上次濕片／便；☐ 最後藥物（名、濃度、ml、時間）；
- ☐ 今日體溫／病徵；☐ 下一個預約；☐ BB 今晚安全睡眠位置；☐ 當值者無酒精／嗜睡藥；

- ☐ 緊急電話同 red book 喺固定位置；☐ 頂唔順時由邊個接手。

資料來源、取捨同版本說明

本書優先採用 NHS、UK Health Security Agency (UKHSA)、GOV.UK、Resuscitation Council UK、地方 NHS／政府及 The Lullaby Trust。網上內容經過以下篩選：① 直接影響死亡、窒息、感染、脫水、餵食或延誤求醫者優先；② 以 2025–26 最新頁面取代舊海報／舊疫苗表；③ 對爭議或頁面入口不一致處，採保守、可操作嘅分流；④ 不加入無證據嘅睡眠訓練承諾、產品宣傳或精確發展『考試』。

插圖由本書重新繪製，只用作姿勢與流程記憶；唔代表個別解剖或取代實作訓練。急救內容以 2025 Resuscitation Council UK 同 NHS 步驟整理。

官方連結（查核於 2026-08-18）

- [1] [NHS : NHS vaccinations and when to have them](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [2] [UKHSA : A guide to immunisation for babies up to 13 months](https://www.gov.uk) — www.gov.uk
- [3] [NHS : MenB vaccine for children](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [4] [UKHSA : Using paracetamol after MenB vaccination](https://www.gov.uk) — www.gov.uk
- [5] [NHS : Rotavirus vaccine](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [6] [NHS : BCG vaccine for tuberculosis](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [7] [GOV.UK : Protecting your baby against hepatitis B](https://www.gov.uk) — www.gov.uk
- [8] [NHS : Sudden infant death syndrome \(SIDS\)](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [9] [The Lullaby Trust : Safer sleep overview](https://www.lullabytrust.org.uk) — www.lullabytrust.org.uk
- [10] [The Lullaby Trust : Co-sleeping](https://www.lullabytrust.org.uk) — www.lullabytrust.org.uk
- [11] [The Lullaby Trust : Swaddling](https://www.lullabytrust.org.uk) — www.lullabytrust.org.uk
- [12] [NHS : Breastfeeding in the first few days](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [13] [NHS : Breastfeeding positioning and attachment](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [14] [NHS : How to tell your baby is getting enough milk](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [15] [NHS : Making up baby formula](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk
- [16] [NHS : Sterilising baby bottles](https://www.nhs.uk) — www.nhs.uk

- [17] [NHS : Bottle-feeding advice](#) — [www.nhs.uk](#)
- [18] [NHS : Expressing and storing breast milk](#) — [www.nhs.uk](#)
- [19] [NHS : Vitamins for children](#) — [www.nhs.uk](#)
- [20] [NHS : What happens straight after birth](#) — [www.nhs.uk](#)
- [21] [NHS : Newborn physical examination](#) — [www.nhs.uk](#)
- [22] [NHS : Newborn hearing test](#) — [www.nhs.uk](#)
- [23] [NHS : Newborn blood spot test](#) — [www.nhs.uk](#)
- [24] [NHS : Getting to know your newborn](#) — [www.nhs.uk](#)
- [25] [NHS : How to change a nappy](#) — [www.nhs.uk](#)
- [26] [NHS : Washing and bathing your baby](#) — [www.nhs.uk](#)
- [27] [NHS : Jaundice in babies](#) — [www.nhs.uk](#)
- [28] [NHS : Baby sleep patterns](#) — [www.nhs.uk](#)
- [29] [NHS : Baby moves and tummy time](#) — [www.nhs.uk](#)
- [30] [NHS : Soothing a crying baby](#) — [www.nhs.uk](#)
- [31] [NHS : When to get urgent medical help for babies and children under 5](#) — [www.nhs.uk](#)
- [32] [NHS : High temperature in children](#) — [www.nhs.uk](#)
- [33] [NHS : Medicines for babies and children](#) — [www.nhs.uk](#)
- [34] [Resuscitation Council UK : 2025 Paediatric basic life support](#) — [www.resus.org.uk](#)
- [35] [NHS : How to resuscitate a child](#) — [www.nhs.uk](#)
- [36] [NHS : How to stop a child from choking](#) — [www.nhs.uk](#)
- [37] [NHS : Baby's first solid foods](#) — [www.nhs.uk](#)
- [38] [NHS : Food allergies and weaning](#) — [www.nhs.uk](#)
- [39] [NHS : Preparing food safely](#) — [www.nhs.uk](#)
- [40] [NHS : Foods to avoid](#) — [www.nhs.uk](#)
- [41] [GOV.UK : Child car seats—the rules](#) — [www.gov.uk](#)
- [42] [NHS : Choosing a baby car seat](#) — [www.nhs.uk](#)
- [43] [NHS : Baby and toddler safety](#) — [www.nhs.uk](#)
- [44] [NHS : Neonatal herpes](#) — [www.nhs.uk](#)
- [45] [NHS : Keeping your baby safe in the sun](#) — [www.nhs.uk](#)
- [46] [NHS : Flat head syndrome](#) — [www.nhs.uk](#)
- [47] [NHS : Baby and toddler tooth care](#) — [www.nhs.uk](#)
- [48] [NHS : Postnatal depression](#) — [www.nhs.uk](#)

[49] [NHS : Postpartum psychosis](#) — [www.nhs.uk](#)

[50] [NHS : Services and support for parents](#) — [www.nhs.uk](#)

[51] [George Eliot Hospital : Maternity services](#) — [www.geh.nhs.uk](#)

[52] [Warwickshire : Health visiting 0–5 years](#) — [warkschildandfamily.co.uk](#)

[53] [Warwickshire County Council : Children and families](#) — [www.warwickshire.gov.uk](#)

版本紀錄

版本	日期	重點
1.0	2026-08-18	按英格蘭 2026 疫苗、2025 RCUK 急救、NHS/Lullaby Trust 安全睡眠及 Warwickshire 本地服務整理

© 2026 | 家庭教育用途。可以打印畀固定照顧者使用；若分享，請連同完整安全警告及來源頁。